Vortrag: Entwicklung der Hybrid-DRG

AutorIn: Anna Maria Raskop, Berlin [6]

Offenlegung finanzieller Interessen:

[1]: BeraterIn (B):	Kommerzielle Vergütung oder Unterstützung der Autorin / des Autors in den letzten drei Jahren in Form von Beraterverträgen (Mitgliedschaft in Gremien, Beiräten, Aufsichtsräten etc.)
[2]: EigentümerIn (E):	Eigentümerinteresse an Arzneimittel/Medizinprodukten (z.B. Patent, Urheberrecht, Verkaufslizenz, etc.)
[3]: InvestorIn (I):	Finanzielles Interesse an Firmen, die eine beschriebene Ausrüstung, ein Verfahren oder Produkte liefern (z.B. Aktienbesitz, AnteilseignerIn etc.)
[4]: MitarbeiterIn (M):	Finanzielles Interesse bei der Produktvermarktung (MitarbeiterIn des Produktherstellers)
[5]: Produkt (P):	Finanzielles Interesse bei der Ausrüstung, dem beschriebenen Verfahren und/oder dem beschriebenen Produkt (z.B. Forschungsunterstützungen, Referentenhonorare, Reisekostenunterstützungen, Stipendien etc.)
[6]: Keine (K):	Keine Interessenskonflikte; keine kommerzielle Unterstützung der vorgelegten Arbeit in irgendeiner Form

KBV KASSENÄRZTLICHE BUNDESVEREINIGUNG

HYBRID-DRG

52. DEUTSCHER KOLOPROKTOLOGEN -KONGRESS AUGSBURG AM 14. MÄRZ 2026



ANNA MARIA RASKOP
ABTEILUNGSLEITERIN MEDIZINISCHE DOKUMENTATION

↗ SACHSTAND SPEZIELLE SEKTORENGLEICHE VERGÜTUNG GEMÄß § 115F SGB V

- ↗ BEAUFTRAGUNG LEISTUNGSKATALOG 2027
- ↗ BEAUFTRAGUNG KALKULATION 2027
- ↗ KALKULATION AB 2031

↗ SACHSTAND AMBULANTES OPERIEREN GEMÄß § 115B SGB V

↗ VERSCHIEDENES



↗ SACHSTAND SPEZIELLE SEKTORENGLEICHE VERGÜTUNG GEMÄß § 115F SGB V

- ↗ BEAUFTRAGUNG LEISTUNGSKATALOG 2027
- ↗ BEAUFTRAGUNG KALKULATION 2027
- ↗ KALKULATION AB 2031

↗ SACHSTAND AMBULANTES OPERIEREN GEMÄß § 115B SGB V

↗ VERSCHIEDENES



Regelungen zur Hybrid-DRG-Vergütung 2026

Gesetzliche Vorgaben

1. Leistungskatalog
   - › Auswahl der Leistungen muss mindestens eine Million vollstationärer Fälle umfassen
   - › Leistungen für Kinder und Menschen mit Behinderung sollen nicht ausgewählt werden

2. Kalkulation
   - › spezielle sektorengleiche Vergütung unabhängig davon, ob die Leistung ambulant oder stationär mit Übernachtung stattfindet
   - › Schrittweise Anpassung der Vergütung auf EBM-Niveau bis 2030

Regelungen zur Hybrid-DRG-Vergütung 2026

gemäß Beschluss 9. ergEBA

- Ersetzen die Hybrid-DRG-Vergütungsvereinbarung 2025
- Alle Regelungsinhalte bleiben bestehen
- Inhalte weitestgehend unverändert

1. Berechtigte Leistungserbringer
2. Zugang gesetzlich Versicherter zu Leistungen nach § 115f SGB V
3. Anlagen
4. Leistungsinhalt der Fallpauschalen
   - keine Änderung oder weitere Konkretisierung zu z. B. Sachkosten (Regelung zu Sprechstundenbedarf bleibt) oder zu pathologischen Leistungen
5. Vergütung der Leistungen
   - Anpassung im Zusammenhang mit der Anlage 3 Zusatzentgelte
6. Qualitätssicherung
7. Abrechnungsverfahren

Regelungen zur Hybrid-DRG-Vergütung 2026

Ersetzen die Hybrid-DRG-Vergütungsvereinbarung 2025 - Inhalte weitestgehend unverändert

- **Anlage 1 Leistungskatalog**
  - Der neue Leistungskatalog enthält 904 OPS-Kodes (bislang 583)
- **Anlage 2 Hybrid-DRG Vergütung**
  - OPS-Kodes aus allen Leistungsbereichen führen in mehrere Hybrid-DRG pro Leistungsbereich
  - Insgesamt 69 Hybrid-DRG (bislang 22): Bessere Differenzierung
  - Preise auf der Basis der Fälle mit einer Verweildauer von bis zu zwei Tagen festgelegt
  - Erster Schritt zur Anpassung des EBM-Niveaus erfolgte nicht
- **Anlage 3 Zusatzentgelte**
  - Im Hybrid-DRG-System sind Zusatzentgelte, wie sie im Krankenhausvergütungssystem existieren, nicht zulässig
- **Anlage 4 Kontextfaktoren**
  - Die Kontextfaktoren der Definitionshandbücher zu den aG-DRG in Anlage 4 werden bestätigt

Regelungen zur Hybrid-DRG-Vergütung 2026 – Anlage 2 Hybrid-DRG

- Vorgabe zur Ambulantisierung von 1 Mio. Fälle
- Gesetzlich vorgegebener Ausschluss von unter 18-Jährige und Menschen mit Behinderung
- Einbeziehung von Fällen mit bis zu 2 Verweildauertagen

Anlage 2 mit 69 Hybrid-DRGs

Bestimmte Hernieneingriffe	9 DRGs
Arthrodesen Zehengelenk/Osteosynthesen	9 DRGs
Eingriffe Galle, Leber, Pankreas	4 DRGs
Exzision Sinus pilonidalis	1 DRG
Entfernung Harnleitersteine	5 DRGs
Ovariektomie	6 DRGs
Eingriffe an Analfisteln	2 DRGs
Eingriffe Hoden/Nebenhoden	2 DRGs
Lymphknotenbiopsien	4 DRGs
Diagnostische Herzkatheter/Koronarinterventionen	15 DRGs
Bestimmte Defibrillatoren	5 DRGs
Ablation bei Herzrhythmusstörungen	3 DRGs
Bestimmte Gefäßinterventionen	4 DRGs

Auswirkungen auf bestehende Hybrid-DRG aus 2025
teils umfangreicher Umbau
- Herausnahme „der Kinder“
- Erweiterung der OPS-Liste
- Notwendige Differenzierung aufgrund z. T. sehr unterschiedlicher Kosten

Die Bezeichnung der Hybrid-DRGs wurden geändert (neue Buchstabenendungen), dadurch eingeschränkte Vergleichsmöglichkeit mit bisherigen Hybrid-DRGs

Neue Hybrid-DRG
Mehrere Splits nach Schweregraden
Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung keine Kenntnis der
- jeweils hinterlegten OPS-Kodes
- zusätzlich erforderlichen Kriterien

Rahmenbedingungen zu Regelungen zur Hybrid-DRG-Vergütung 2026

- Ergänzter erweiterter Bewertungsausschuss als Entscheidungsgremium etabliert
- Möglichkeit der Bewertung der Hybrid-DRG weiterhin sehr begrenzt
  - unklare und intransparente Kalkulationsgrundlage
  - fehlende Zuordenbarkeit von OPS-Kodes zu DRG-Vergütung – „alles hängt am Grouper“

➡ Forderungen der KBV nach mehr Transparenz und verstärkte Berücksichtigung der vertragsärztlichen Belange

Bekanntmachung des BMG nach den §§ 295 und 301 SGB V zur Anwendung des OPS

› Bisher wurde die Anwendung „in der vertragsärztlichen Versorgung nach § 295 SGB V“ auf die OPS-Kodes des Anhang 2 zum EBM beschränkt:

> Für die Anwendung des OPS in der vertragsärztlichen Versorgung nach § 295 SGB V wird zusätzlich bestimmt, dass ausschließlich die vom Bewertungsausschuss für die ärztlichen Leistungen gemäß § 87 SGB V im Anhang 2 des einheitlichen Bewertungsmaßstabs aufgeführten Kodes zu verwenden sind.

› Damit war nicht eindeutig geregelt, ob OPS-Kodes aus dem AOP-Katalog (§ 115b SGB V) bzw. dem Hybrid-DRG-Leistungskatalog (§ 115f SGB V), die nicht Inhalt des Anhangs 2 zum EBM sind, von Vertragsärzten verwendet werden dürfen

› Für 2026 erfolgt eine Klarstellung:

> Für die Anwendung des OPS durch die nach § 95 Absatz 1 Satz 1 SGB V an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Leistungserbringer wird zusätzlich bestimmt, dass ausschließlich die Kodes zu verwenden sind, die
> - vom Bewertungsausschuss für die ärztlichen Leistungen gemäß § 87 SGB V im Anhang 2 des einheitlichen Bewertungsmaßstabs aufgeführt,
> - im Katalog gemäß § 115b SGB V vereinbart oder
> - für die Vergütung gemäß § 115f SGB V ausgewählt sind.

Prä-/postoperative Behandlung nach Hybrid-DRG im EBM

708. und 757. Beschluss des BA

- Zur Abgrenzung und Vergütung von Untersuchungen und Behandlungen, die prä- und postoperativ in der hausärztlichen Versorgung anfallen können, wurden bis **zum 31. Dezember 2025 befristete Übergangsregelungen** im Kapitel 31 EBM festgelegt
  - Präoperative Leistungen im Zusammenhang mit Hybrid-DRG: Übergangslösung gemäß Präambel 31.1.1, Nr. 3 (GOP des Abschnitts 31.1.2 berechnungsfähig)
  - Postoperative Leistungen im Zusammenhang mit Hybrid-DRG: Übergangslösung gemäß Präambel 31.4.1, Nr. 6 (GOP des Abschnitts 31.4.2 und 31.4.3 berechnungsfähig)

➡ Verlängerungsbeschluss durch den Beschluss des 820. Bewertungsausschuss zum 31. Dezember 2026

↗ SACHSTAND SPEZIELLE SEKTORENGLEICHE VERGÜTUNG GEMÄß § 115F SGB V

- ↗ **BEAUFTRAGUNG LEISTUNGSKATALOG 2027**
- ↗ BEAUFTRAGUNG KALKULATION 2027
- ↗ KALKULATION AB 2031

↗ SACHSTAND AMBULANTES OPERIEREN GEMÄß § 115B SGB V

↗ VERSCHIEDENES



Verhandlungsschwerpunkte in 2026 für Hybrid-DRGs 2027

Gesetzliche Vorgaben:

1. Leistungskatalog
   bis 31. März 2026 jährliche Überprüfung des Leistungskataloges (§ 115f Abs. 2 Satz 1 SGB V)
   - Dabei:
     - keine Erhöhung der vom Katalog umfassten vollstationären Fälle, d. h. in 2027 müssen eine Mio. Fälle umfasst sein.
     - keine Kinder und Menschen mit Behinderung
   - Dafür:
     - bis 15. Februar 2026 Auftrag an Institute für einen Vorschlag
2. Kalkulation
   bis 30. Juni 2026 sind die Fallpauschalen für 2027 zu vereinbaren (§ 115f Abs. 1 Satz 9 SGB V)
   - Dafür:
     - bis 15. Mai Auftrag an Institute für einen Vorschlag zur Kalkulation
   - Dabei:
     - gesetzlich vorgegebener Vorschlag der Institute zur schrittweisen Anpassung der Vergütungen auf EBM-Niveau im Jahr 2030
3. Evaluation
   bis 30. Juni 2026: Erster Evaluationsbericht der Institute an BMG (§ 115f Abs. 5 Satz 2 SGB V)

Verhandlungsschwerpunkte in 2026 für Hybrid-DRGs 2027

1. Leistungskatalog
   - › keine Katalogerweiterung in 2027
   - › Wiederaufnahme Kinder und Menschen mit Behinderung (Gesetzgeber) !

2. Kalkulation
   - › Neukalkulation wegen der Wiederaufnahme von Kindern und behinderten Menschen !
   - › keine Anpassung in Richtung EBM-Niveau (Gesetzgeber) !
   - › Transparenz und Lösung für zum Teil unzureichende Vergütung von Sachkosten
   - › Forderung nach Abgrenzung der Fallpauschalen für Pathologie

3. Auswertung Evaluation für Vorbereitung Katalogerweiterung in 2028 (1,5 Mio. vollstationäre Fälle)

4. Schaffen einer Kalkulationsgrundlage für H-DRG ab 2031: fallbezogene empirische Kostendaten des ambulanten und stationären Bereichs

Beauftragung Leistungskatalog 2027

Dreiseitige Beauftragung der Institute ist fristgerecht am 13. Februar 2026 erfolgt

Kernpunkte der Beauftragung:

- Keine Erweiterung im Sinne von neuen Leistungen/Leistungsbereichen
- Aufnahme bzw. Streichung von Leistungen in bestehenden Leistungsbereichen unter Berücksichtigung von:
  - Vorschlägen aus bisherigen Hybrid-DRG-Weiterentwicklungsverfahren
  - Änderungen bei stationären und ambulanten NUB
  - Gesetzlichen Anpassungen (insb. bei Versorgung von Kindern und Menschen mit Behinderung)
    - Mögliche Variantenbildungen
  - Fachlichen Rückmeldungen der Vertragsparteien – diese wurden getrennt bei den Instituten eingereicht

Beauftragung Leistungskatalog 2027

- Die Institute haben das Ergebnis der Beauftragung bis zum 15. März 2026 an die Vertragsparteien zu übermitteln

- Die Vertragsparteien haben eine dreiseitige Vereinbarung bis 31. März 2026 zum Leistungskatalog 2027 zu schließen

↗ SACHSTAND SPEZIELLE SEKTORENGLEICHE VERGÜTUNG GEMÄß § 115F SGB V

- ↗ BEAUFTRAGUNG LEISTUNGSKATALOG 2027
- ↗ **BEAUFTRAGUNG KALKULATION 2027**
- ↗ KALKULATION AB 2031

↗ SACHSTAND AMBULANTES OPERIEREN GEMÄß § 115B SGB V

↗ VERSCHIEDENES



Beauftragung Kalkulation 2027

KBV-Forderung zur Berechnung

- Vorgehen bei der Kalkulation für das Jahr 2026 wird grundsätzlich beibehalten
- Geänderte gesetzliche Grundlage mit der Einbeziehung von Kindern und behinderten Menschen wird umgesetzt
- Berechnungen erfolgen auf Basis der Datengrundlage des InEK aus dem Jahr 2025 und des InBA aus dem Jahr 2023
- Die Institute werden beauftragt, Transparenz über die Homogenität und die Verteilung der Sachkosten herzustellen
- Ggf. sind perspektivisch die Verträge zwischen InEK und Kalkulationskrankenhäusern so anzupassen, dass Transparenz möglich wird
- Beratungen dazu wurden am 6. März aufgenommen

Beauftragung Kalkulation 2027

- Die Beauftragung der Institute hat bis spätestens zum 15. Mai 2026 zu erfolgen
- Die Vertragsparteien haben eine dreiseitige Vereinbarung bis zum 30. Juni 2026 bzw. bei angepasster Rechtslage bis zum 15. September 2026 zur Kalkulation 2027 zu beschließen

↗ SACHSTAND SPEZIELLE SEKTORENGLEICHE VERGÜTUNG GEMÄß § 115F SGB V

- ↗ BEAUFTRAGUNG LEISTUNGSKATALOG 2027
- ↗ BEAUFTRAGUNG KALKULATION 2027
- ↗ **KALKULATION AB 2031**

↗ SACHSTAND AMBULANTES OPERIEREN GEMÄß § 115B SGB V

↗ VERSCHIEDENES



Gesetzesgrundlage

§ 115f Absatz 1a SGB V:

„Spätestens in der bis zum 30. Juni 2030 zu schließenden Vereinbarung sind die nach Absatz 1 Satz 2 zu kalkulierenden Fallpauschalen auf Grundlage **fallbezogener empirischer Kostendaten des ambulanten und stationären Bereichs** festzulegen.
[…]
Die Vertragsparteien nach Absatz 1 Satz 1 **beauftragen** das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus und das in § 87 Absatz 3b Satz 1 genannte Institut gemeinsam **bis zum 30. April 2025**, einen Vorschlag für ein Konzept zur Festlegung der Fallpauschalen nach Satz 1 zu erarbeiten.
Auf der Grundlage dieses Vorschlags **vereinbaren die Vertragsparteien bis zum 31. Dezember 2025 das Konzept zur Festlegung der Fallpauschalen nach Satz 1** und legen dieses Konzept dem Bundesministerium für Gesundheit vor.“

Verfahrensvereinbarung zur Umsetzung des gesetzlichen Auftrags

› Vertragsparteien haben zum 17. Dezember 2025 zunächst Eckpunkte zum Kalkulationsmodell für eine sektorenübergreifende Vergütung sowie zur Erhebung der Daten und der Stichprobe im ambulanten Bereich beschlossen:

1. Geeignetes Kalkulationsmodell für eine sektorenübergreifende Vergütung
2. Erhebung im ambulanten Bereich – Festlegung der zu erhebenden Daten
3. Stichprobe im ambulanten Bereich – Freiwilligkeit der Teilnahme
4. Voraussetzungen/Rahmenbedingungen

› Details werden im Jahr 2026 näher ausgearbeitet
› Die wesentlichen Vorgaben sind bis zum 30. Juni 2026 festzulegen

- ↗ **SACHSTAND SPEZIELLE SEKTORENGLEICHE VERGÜTUNG GEMÄß § 115F SGB V**
  - ↗ BEAUFTRAGUNG LEISTUNGSKATALOG 2027
  - ↗ BEAUFTRAGUNG KALKULATION 2027
  - ↗ KALKULATION AB 2031
- ↗ **SACHSTAND AMBULANTES OPERIEREN GEMÄß § 115B SGB V**
- ↗ **VERSCHIEDENES**



Sachstand ambulantes Operieren gemäß § 115b SGB V

Verhandlungsergebnis für 2026

- AOP-Vertrag
  - Finanzierung der ärztlichen Weiterbildung - Überprüfungsauftrag für das Jahr 2026 festgelegt
  - redaktionelle Anpassungen

- Anpassung der Anlage 1 zum AOP-Vertrag (AOP-Katalog)
  - Aufnahme eines OPS-Kodes in den Abschnitt 1, ansonsten keine Erweiterung:
  - Kataloganpassung an die OPS-Version 2026
  - Verlängerung der Übergangsreglung zur Vergütung von Leistungen, die bisher nicht im EBM enthalten sind (sogenannte „Sternchenleistungen“) bis 30. Juni 2026

Sachstand ambulantes Operieren gemäß § 115b SGB V

Verhandlungsergebnis für 2026

- Anpassung der Anlage 2 zum AOP-Vertrag (Kontextfaktoren)
  - Strukturelle Anpassungen im augenärztlichen Bereich aufgrund von OPS-Änderungen im Zusammenhang mit dem Wegfall des Kennzeichens „B“ für beidseitige Eingriffe

- Anpassung der Anlage 3 (Liste der Frakturzuschläge inkl. Vergütung)
  - Aktualisierung der Bewertungen der Frakturzuschläge aufgrund der Anpassung des Orientierungswertes zum 1. Januar 2026

Sachstand ambulantes Operieren gemäß § 115b SGB V

Themenschwerpunkte in 2026 für 2027

- AOP-Vertrag
  - Finanzierung der ärztlichen Weiterbildung im Rahmen der Vergütung von ambulanten Operationen
  - Schweregraddifferenzierung

- Anlage 1 zum AOP-Vertrag (AOP-Katalog)
  - Erweiterung des Leistungskataloges (BV-Abfrage)
    - inkl. Abfrage zur Aufnahme operativer Leistungen des Hybrid-DRG-Leistungskataloges in den Anhang 2 zum EBM und ggf. in den Abschnitt 1 des AOP-Kataloges
  - Abschaffung der Übergangsreglung zur Vergütung von Leistungen, die bisher nicht im EBM enthalten sind (sogenannte „Sternchenleistungen“) bis 30. Juni 2026

➡ Erster Austausch der Verhandlungspartner ist für den 17. März 2026 vorgesehen.

- ↗ **SACHSTAND SPEZIELLE SEKTORENGLEICHE VERGÜTUNG GEMÄß § 115F SGB V**
  - ↗ BEAUFTRAGUNG LEISTUNGSKATALOG 2027
  - ↗ BEAUFTRAGUNG KALKULATION 2027
  - ↗ KALKULATION AB 2031
- ↗ **SACHSTAND AMBULANTES OPERIEREN GEMÄß § 115B SGB V**
- ↗ **VERSCHIEDENES**



Sachstand aus der Gesetzgebung

Änderungsanträge zum Krankenhausreformanpassungsgesetz (ÄA KHAG) – Hybrid-DRG

- Anpassung der Frist für die jährliche Festlegung der Vergütung der Hybrid-DRG zwecks Harmonisierung mit der Entwicklung des aG-DRG-Systems
- Fallzahlausweitung ab 2028 unter Berücksichtigung der Evaluationsergebnisse.
- Aufhebung Ausschluss von Kindern und Menschen mit Behinderung von den Hybrid-DRG
- Anpassung Fristen für die Evaluation und Adressatenkreis für den Evaluationsbericht

- KBV begrüßt grundsätzlich den Änderungsantrag Hybrid-DRG fordert ergänzend die Streichung der Absenkung der Vergütung auf EBM-Niveau bis 2030 (§ 115f Abs. 1 Satz 8)

- Sitzungswochen im März sind abzuwarten – frühester Bundesrat am 27. März zu erreichen

DEUTSCHLAND MUSS #PRAXENLAND BLEIBEN

Praxenland.de